

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/1736/25

הצעת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי
בחקיקה ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 –

(1) בסעיף 6(א), אחרי פסקה (12) יבוא:

"(13) השמת נזקק סיעודי במעון;

(14) טיפול סיעודי קהילתי, לרבות תמיכה וליווי של המטפל העיקרי
בנזקק."

(2) בסעיף 9(ב), אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) על אף האמור בפסקה (1), עלות מרכיב שירותי הסיעוד בסל
תתעדכן מדי שנה בשיעור עליית מדד יוקר שירותי הסיעוד שתפרסם
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מרכיבי מדד יוקר שירותי הסיעוד
ייקבעו בידי שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ושר הרווחה והביטחון
החברתי ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ואולם

(1) מחצית לפחות ממדד יוקר שירותי הסיעוד תיקבע
בהתאם לשיעור השינוי בשכר הממוצע במשק;

(2) מדד יוקר שירותי הסיעוד לא יושפע מדמי הביטוח
הנגבים."

(3) בסעיף 13(א)(1), אחרי "בריאות" יבוא "ודמי ביטוח סיעוד";

(4) בסעיף 14, בכל מקום, במקום "5%" יבוא "5.65%";

- (5) בסעיף 15, בכל מקום, אחרי "ביטוח בריאות" יבוא "ודמי ביטוח סיעוד", ובכל מקום אחרי "ביטוח הבריאות" יבוא "ודמי ביטוח הסיעוד";
- (6) בסעיף 20, בפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם דמי ביטוח סיעוד המשולמים מכוח סעיף 14(ג), ישמשו למטרת סיעוד בלבד."
- (7) אחרי סעיף 23 א יבוא :

"פרק ה'1: השמת נזקק סיעודי במעון או במוסד סיעודי

הגדרות 23ב. בחוק זה –

"זקן סיעודי" ו"זקן תשוש" – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס"א–22001;

"זקן סיעודי מורכב" – אדם הזקוק בנוסף לעזרה בפעולות היומיומיות גם להשגחה רפואית עקב עירויים קבועים, פצעי לחץ חמורים או עקב התערבויות רפואיות קבועות אחרות;

"מוסד סיעודי" – מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים סיעודיים או תשושי נפש;

"נזקק סיעודי תלוי מאוד" – מבוטח שהגיע לגיל פרישה ומבדיקת קופת החולים עולה כי אין שירותים תומכים עבורו בקהילה הסמוכה למקום מגוריו או ששירותים אלה אינם מספיקים על מנת לשמר את רמת תפקודו, וכן מתקיים בו אחד מאלה:

- (1) בבדיקת מידת התלות בעזרת הזולת שערך המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 23 נמצא שהוא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת לביצוע מרבית פעולות היום-יום או זקוק להשגחה קבועה;

² ק"ת התשס"א, עמ' 338.

(2) נקבע על ידי רופא מומחה בתחום הפסיכיאטריה או בתחום הגריאטרי כי הוא תשוש נפש ;

"קהילה סמוכה" – במרחק של עד 20 קילומטרים מבית מגוריו של המבוטח ;

"תשוש נפש" – אדם שזקוק להשגחה במרבית שעות היממה בשל ירידה במצבו השכלי, אשר נובעות ממנה פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, כגון ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה ביכולת הזיכרון או חוסר התמצאות במקום ובזמן.

זכאות להשמה 23ג. (א) כל מבוטח שהוא נזקק סיעודי תלוי מאוד יהיה זכאי לקבל מקופת החולים שבה הוא רשום הפניה לאשפוז במוסד סיעודי הקשור בהסכם עם הקופה, בהתאם למצבו הרפואי והתפקודי.

(ב) האחריות לאספקת שירותי אשפוז במוסד סיעודי לנזקק סיעודי תלוי מאד, תהיה על קופת החולים ; שירותי האשפוז יינתנו במוסדות שמספקים שירותים בחלוקה לסטטוס זקן סיעודי, זקן סיעודי מורכב ותשוש נפש.

(ג) לא תתקשר קופת החולים עם מוסד סיעודי שלא מתקיימים בו התנאים שעליהם הורה המנהל, לעניין הרמה הרצויה של המוסדות הסיעודיים, לרבות בעניין רמת הטיפול הרפואי, רמת ההשגחה, היקף התשתיות הפיזיות וכוח האדם במקום ואיכותם, היחס כלפי השוהים במוסד ומרכיבים נוספים הנוגעים להפעלה נאותה של המוסד, ולא תבצע בו השמה לפי הוראות פרק זה.

השתתפות עצמית 23ד. (א) מבוטח שהוא נזקק סיעודי תלוי מאד וזכאי לאשפוז במוסד סיעודי לפי סעיף 23ג, יידרש לשאת בהשתתפות עצמית במימון האשפוז, שתשולם לקופת החולים.

(ב) קביעת רמת ההשתתפות העצמית תבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם למבחן הכנסה של הזכאי ובן זוגו בלבד.

(ג) שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו את שיעור ההשתתפות העצמית של המבוטחים במימון האשפוז; בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, סכום ההשתתפות העצמית למבוטח בחודש לא יעלה על סכום של 6,000 שקלים חדשים; הסכום האמור בסעיף קטן זה יתעדכן בהתאם להוראות סעיף 40א(ז).

פרק ח'2: עזרה סיעודית קהילתית

23ה. בפרק זה ובפרט 31 לתוספת השנייה –

הגדרות

"ביצוע פעולת יום-יום" – השלמת פעולת יום-יום במלואה;

"גיל פרישה" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004³;

"השגחה" – השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים;

"מבוטח זכאי" – מי שמתקיימים בו התנאים לפי סעיף 123 ו-123ז;

"ליקוי" – ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה;

"מטפל עיקרי" – מי שנושא בעיקר נטל הדאגה למתן עזרה רצופה, קבועה ואינטנסיבית בפעולות יום-יום של המבוטח הזכאי ומנהל את מערכות חייו ללא כל תמורה כספית;

"פעולות יום-יום" – קימה ושכיבה, לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית;

³ ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

"שעת סיעוד" – שעת עבודה של מטפל סיעודי, במתן עזרה סיעודית ואישית למבוטח הזכאי, בבית המבוטח, כאמור בפרט (1) בטור א' ללוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי;

"שירותי סיעוד אחרים" – כמפורט בלוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי, למעט שעות סיעוד;

"השרים" – שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי.

זכאות לשעות סיעוד²³. מבוטח שהגיע לגיל פרישה והוא מוגבל בפעולות היום-יום או זקוק להשגחה, רשאי לפנות לקופת החולים בבקשה להכיר בו כזכאי לשעות סיעוד או לשירותי סיעוד אחרים (בפרק זה – תביעה להכרה במצב סיעודי).

מבחני תלות
וקביעת שיעור
הזכאות

23. (א) המוסד לביטוח לאומי יערוך למבוטח בדיקת מידת תלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום או בשל הצורך בהשגחה.

(ב) בהתאם לבדיקה יסווג המוסד לביטוח לאומי את רמת התפקוד של המבוטח הזכאי כאמור, באחת משלוש רמות התלות הקבועות בפרט 31 בתוספת השנייה, או שיקבע כי אין הוא תלוי באופן משמעותי בעזרת הזולת, לעניין בביצוע פעולות היום-יום או בשל הצורך בהשגחה; תוצאות הבדיקה ונימוקיה ימסרו בכתב למבוטח ולקופת החולים שבה הוא חבר.

(ג) מבוטח שנמצא כי רמת תפקודו היא אחת משלוש רמות התלות, יהיה זכאי לשעות סיעוד או לשירותי סיעוד אחרים, בהיקף שייקבע לפי רמת התלות שבה סווג כמפורט בתוספת השנייה ובהתאם לרמת הכנסתו לפי מבחני ההכנסה שנערכו לו לפי סעיף 23ח.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שמלאו לו 75 שנים רשאי לבחור כי בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת שתיערך לו תבוצע בידי רופא מומחה בגריאטריה, במסגרת עבודתו במוסד רפואי, ובלבד שהמבוטח לא יידרש לשלם ולא ישלם בפועל תשלום כלשהו עבור הבדיקה, להוציא תשלומים החלים על חברים בקופה כמשמעותם בסעיפים 7 ו-8.

מבחני הכנסה כתנאי לזכאות
23ח. (א) לעניין סעיף זה –

"תובע" – מי שהגיש תביעה להכרה במצב סיעודי לפי סעיף 123 ;

"בן זוג" – בן זוגו של התובע הגר עמו ;

"ילד" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי.

(ב) זכאותו של מבוטח זכאי לשעות סיעוד או לשירותי סיעוד אחרים, בהתאם לרמת התלות שבה סווג כאמור בתוספת השנייה, מותנית במבחני הכנסה לפי סעיף קטן (ג) ;

(ג) זכאות מלאה לשעות סיעוד או לשירותי סיעוד אחרים בהתאם לרמת התלות שבה סווג כאמור בתוספת השנייה תתקיים אם הכנסתו החודשית של המבוטח אינה עולה על סכומים כלהלן, לפי העניין :

(1) ליחיד – סכום השווה לשכר הממוצע ;

(2) מי שיש עמו בן זוג – סכום השווה ל-150% מהשכר הממוצע ;

(3) למי שיש עמו ילד – סכום נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות (1) או (2), השווה ל-50% השכר הממוצע בעד כל ילד.

(ד) עלתה הכנסתו החודשית של המבוטח הזכאי על הסכום כאמור בסעיף קטן (ג), ולא עלתה על הסכומים שלהלן, לפי העניין, המבוטח הזכאי יהיה זכאי למחצית מהזכאות המלאה לשעות סיעוד או לשירותי סיעוד אחרים האמורים בסעיף קטן (א):

(1) ליחיד – סכום השווה ל-150% מהשכר הממוצע;

(2) למי שיש עמו בן זוג – סכום השווה ל-225% מהשכר הממוצע;

(3) למי שיש ילד – סכום נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות (1) או (2), השווה ל-75% מהשכר הממוצע בעד כל ילד.

(ה) בחישוב ההכנסה לפי סעיף זה תובא בחשבון הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, אף אם לא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט –

(1) קצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק הביטוח הלאומי;

(2) הענקות לחיילים ולבני משפחותיהם לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התשי"ט-1949⁴;

(3) גמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

(4) דמי מחיה לאלמנה או ליתום לפי סעיף 144 לחוק הביטוח הלאומי;

(5) קצבה מיוחדת לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978⁵;

(6) גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התשי"ע-2010⁶;

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 13.

⁵ ק"ת התשל"ט, עמ' 83.

⁶ ק"ת התשי"ע, עמ' 810.

(7) גמלה נוספת לנכה לפי סעיף 251

לחוק הביטוח הלאומי;

(8) תשלומים לנזקק לפי חוק שירותי

הסעד, התשי"ח-1958⁷;

(9) הכנסות משכר דירה למבוטח

שמשכיר דירה בבעלותו ומתגורר בדירה

שהוא שוכר לצורך מגורים, אולם אם

המבוטח מכניס משכר דירה יותר מאשר

הוא מוציא, תובא ההכנסה העודפת

בחשבון;

(10) תגמולי סיעוד, לרבות תגמולים

מביטוח פרטי;

(11) הכנסה שמקורה בקצבה חודשית

המשולמת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או

מכוח סעיף 3 לחוק הטבות לניצולי שואה,

התשס"ז-2007⁸, או המשולמת על ידי

מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים

ועוזריהם.

(ו) על אף האמור בכל דין, במבחני ההכנסה לפי

סעיף זה לא יובאו בחשבון הכנסות בן משפחתו של

התובע שאינו בן הזוג.

23ט. (א) קופת חולים תכין, למבוטח הזכאי, בתיאום

עמו, תכנית לקבלת שעות הסיעוד או שירותי סיעוד

אחרים (בסעיף זה – התכנית), וכן תציין את נותן

השירות, בכפוף לזכותו של המבוטח לבחירה מבין

נותני השירותים לפי סעיף 23(א);

(ב) לעניין סעיף 3, שעות סיעוד ושירותי סיעוד

אחרים לפי פרק זה יינתנו בסמיכות למקום מגורי

המבוטח הזכאי; לעניין זה, "סמיכות למקום

מגורים" – מרחק שלא עולה על 20 קילומטרים

מבית המגורים של המבוטח.

תכנית לקבלת

שעות סיעוד או

שירותי סיעוד

אחרים

⁷ ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

⁸ ס"ח התשס"ז, עמ' 47.

(ג) קופת החולים רשאית לקבוע כי התכנית תחול לזמן מוגבל, ותיבחן מחדש מדי תקופה שתיקבע; קופת החולים תנמק את החלטתה לפי סעיף קטן זה ותמסור העתק ממנה למבוטח.

(ד) אספקת שעות הסיעוד בידי המטפל הסיעודי למבוטח הזכאי תהיה באחריות קופת החולים ותבוצע באמצעות עובדים מטעמה או באמצעות נותני שירות הקשורים עמה בהסכם.

(ה) קופת החולים תשמש גורם מתאם, מבקר ומפקח על נותני השירותים ואיכות שירותיהם.

(ו) היה המבוטח מרותק לביתו או מתגורר בגפו, תתייחס התכנית למצבו ותכלול גם מענה רפואי ואישי באמצעות צוות רב תחומי הכולל רופא מומחה לגריאטריה, אחות, עובד סוציאלי, תזונאי, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ואנשי מקצוע נוספים לשיקול דעתה של קופת החולים.

(ז) השרים יקבעו את סל השירותים הבסיסי שיינתנו לפי פרק זה למבוטח במסגרת שעת סיעוד או במסגרת שירות משירותי הסיעוד האחרים, בביתו ובקהילתו, וכן יקבע את סוג השירותים הרפואיים והסיעודיים, זמינותם ואיכותם, שבהם תחויב לעמוד קופת החולים או נותני השירותים מטעמה.

(ח) קופת החולים אחראית למתן ייעוץ וליווי אישי לכל מבוטח זכאי, לשם מיצוי זכויותיו הרפואיות והסוציאליות הנוגעות לטיפול הסיעודי בו, מול כל הגורמים לרבות עקב שינוי במצבו הרפואי או הכלכלי.

(ט) קופת חולים תקיים פיקוח ובקרה על תפקודו המקצועי של נותן שירותי סיעוד שעמו היא התקשרה, לרבות חברה או עמותת סיעוד; קבעה הקופה כי התאגיד אינו עומד בחובותיו או כי אינו נותן למבוטח הזכאי שירות ברמה נאותה, תפסיק הקופה את ההתקשרות עמו.

(י) זקוק המבוטח הזכאי למכשירי ניידות ושיקום כאמור בסעיף 32 לתוספת השניה, אחראית קופת החולים לספק לו את המכשירים.

זכאות לתשלום 23. (א) בסעיף זה –

חודשי חלף שעות

סיעוד

"בן משפחה" – הורה, בן זוג, ילד, אח או אחות, וכן בן זוגו וילדו של כל אחד מהם;

"מטפל סיעודי" – מי שנותן שירותי סיעוד בעצמו, תמורת שכר, ומתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא אינו בן משפחה של המבוטח הזכאי, או שהוא בן משפחה וקופת החולים לא הביעה התנגדות מטעמים רפואיים לכך שיטפל בו;

(2) אם הוא עובד זר – הוא אינו שוהה שלא כדין בישראל, כמשמעותו בסעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952⁹;

"שירותי סיעוד" – שירותים המיועדים לסייע בביצוע פעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק בית, לרבות שירותים הקבועים בלוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי.

(ב) על אף האמור בסעיף 23ח, מבוטח זכאי רשאי, לבחור לקבל תשלום חודשי חלף קבלת שירותי סיעוד לפי תכנית כאמור בסעיף 23ט (בסעיף זה – תשלום חודשי).

⁹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

(ג) מבוטח זכאי שבחר בתשלום חודשי, יקבל תשלום בסכום השווה למכפלת הסכום לשעת סיעוד במספר שעות הסיעוד שהיו מגיעות לו בהתאם לרמת התלות שבה סווג ולהכנסתו; הסכום לשעת סיעוד יהיה בסך 50 שקלים חדשים; הסכום לשעת סיעוד יעודכן בהתאם לשיעור העדכון ולמועדי העדכון של שכר המינימום לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

(ד) (1) קופת חולים תבצע הדרכה למטפל הסיעודי המועסק בביתו של המבוטח הזכאי לשם טיפול משקם, משמר ומונע, תקיים פיקוח ובקרה על מטפל סיעודי ותקבע אם הוא כשיר ומתאים לטפל במבוטח, בהתחשב בצורכי המבוטח, וכן אם היקף שירותי הסיעוד הניתנים למבוטח בפועל בידי המטפל הסיעודי ורמתם, עונים על צרכיו.

(2) קבעה הקופה כי המטפל הסיעודי אינו כשיר או אינו מתאים לטפל במבוטח הזכאי או כי שירותי הסיעוד הניתנים למבוטח על ידו אינם עונים על צרכיו, רשאית הקופה לשלול את הזכות לקבל תשלום חודשי לפי סעיף זה, ובלבד שתספק למבוטח הזכאי את שעות הסיעוד ושירותי הסיעוד האחרים שהוא זכאי להם בסמיכות וברציפות להפסקת התשלום.

מטפל עיקרי 23יא. קופת החולים תהיה אחראית לקיום קשר שוטף עם מטפל עיקרי במבוטח הזכאי לשירותי סיעוד, לרבות בנושאים האלה –

(1) הדרכה בביתו של המבוטח הזכאי בנוגע לטיפול בו;

(2) עדכון המטפל העיקרי בעקבות מעקב תקופתי אחר מצבו הרפואי והסיעודי של המבוטח הזכאי;

(3) העמדת סל שירותים הכולל טיפול לתמיכה רגשית וליווי מקצועי לרשות המטפל העיקרי;

(4) השתתפות בהוצאה בגין הבראה, פעמיים בשנה, בסכום השווה לקצובת הבראה ונופש בעד 3 ימים המשולמת באותה שנה לעובד המדינה.

בדיקת תלות ובדיקה מחדש 23יב. המוסד לביטוח לאומי יבדוק מחדש, לפי בקשתו של המבוטח הזכאי, את תפקודו ומידת התלות שלו, אם חל שינוי במצבו הבריאותי או התפקודי.

זכאות לתקופה מוגבלת 23יג. קופת החולים רשאית לקבוע כי הזכאות לשעות סיעוד ולשירותי סיעוד אחרים תינתן לתקופה מוגבלת שקבעה, כאשר מצבו התפקודי של המבוטח הזכאי אינו יציב, ובלבד שתנמק את החלטתה בכתב.

סייג לזכאות של מאושפז במוסד 23יד. (א) מבוטח הנמצא במוסד סיעודי לפי פרק ה'1 יחולו עליו הוראות סעיף 307 לחוק הביטוח הלאומי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שאושפז בבית חולים שאינו מוסד סיעודי, יהיה זכאי לשעות סיעוד לתקופה שאינה עולה על 14 ימים ממועד אשפוזו.

חידוש זכאות לאחר אשפוז 23טו. מבוטח שהופסקה זכאותו לשעות סיעוד בשל כך שאושפז בבית חולים או במוסד סיעודי, ושחרר מאשפוז בתוך תקופה של 90 ימים, או תקופה ארוכה יותר שאישרה קופת החולים, יהיה זכאי לשעות סיעוד ממועד שחרורו, בשיעור שנקבע לגביו טרם אשפוזו, לפחות.

מניעת כפל זכויות 23טז. מי שזכאי לשעות סיעוד לפי חוק זה וכן לקצבה מיוחדת לפי סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי או לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיפים 206 ו-206א לחוק האמור, הברירה בידו לבחור באחת מהן.

זכאות למי שטרם 23יז. השרים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הגיע לגיל פרישה העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאים לקבוע תנאים שבהם תחול הזכאות לשעות סיעוד ולשירותי סיעוד אחרים גם על מי שטרם הגיע לגיל הפרישה.

ועדה לעררים על 23יח. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת קופת החולים לעניין רמת התפקוד שלו או רמת התלות שבה סווג או התכנית שנקבעה לו רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים בת שלושה חברים המורכבת מרופא מומחה בגריאטריה או ברפואה פסיקלית ושיקום, שהוא יושב הראש, מעובד סוציאלי ומאחות מוסמכת כמשמעותה לפי פקודת בריאות העם, 1940¹⁰.

(ב) השרים יקבעו רשימת חברים בוועדה לעררים, מבין רופאים מומחים בגריאטריה או ברפואה פסיקלית ושיקום, אחיות מוסמכות ועובדים סוציאליים (בסעיף זה – הרשימה); רק רופא, אחות או עובד סוציאלי כאמור המועסק על ידי שירותי הבריאות הממלכתיים ובכלל זה בתי החולים הממשלתיים וקופות החולים, זכאי להיכלל ברשימה.

(ג) השרים יקבעו הוראות לעניין הרכב הוועדה לעררים, מותביה, סמכויותיה וסדרי עבודתה וכן לעניין המועדים והדרכים להגשת הערר ולדיון בו.

(ד) הוועדה לעררים תתעד את ישיבותיה בפרוטוקול ותמסור למערער העתק לרבות את ההחלטה הסופית על נימוקיה.

(ה) ערעור על החלטת הוועדה לעררים יוגש לבית הדין האזורי לעבודה.

¹⁰ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

מוקד מידע בנושאי 23יט. קופת חולים תקים מוקד מידע בטלפון ובאינטרנט
סיעוד שירכו את כל המידע הנוגע לתביעה להכרה במצב
סיעודי, לאשפוז סיעודי, לשעות סיעוד או שירותי
סיעוד אחרים ולתשלום חודשי חלק שעות
סיעוד." ;

(9) בתוספת השנייה, אחרי סעיף 30 יבוא :

31. "עזרה סיעודית קהילתית (הזכאות מותנית גם במבחן הכנסה) :

(א) רמת תלות 1 - מבוטח שהגיע לגיל פרישה, ושכנוצאה
מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע פעולות
היום-יום, או הזקוק להשגחה במידה מסוימת – זכאי ל-10
שעות סיעוד בשבוע ;

(ב) רמת תלות 2 - מבוטח שהגיע לגיל פרישה, ושכנוצאה
מליקוי נהיה תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת לביצוע
פעולות היום-יום או הזקוק להשגחה, ברוב שעות היממה – זכאי
ל-25 שעות סיעוד בשבוע ; מבוטח המעסיק מטפל, זכאי בנוסף
גם לשירותי סיעוד אחרים של שימוש במרכז יום שלוש פעמים
שבוע ;

(ג) רמת תלות 3 - מבוטח שהגיע לגיל פרישה, ושכנוצאה
מליקוי נהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות
היום-יום בכל שעות היממה, או הזקוק להשגחה מתמדת – זכאי
ל-40 שעות סיעוד בשבוע ; מבוטח המעסיק מטפל, זכאי בנוסף
גם לשירותי סיעוד אחרים של שימוש במרכז יום חמש פעמים
שבוע ;

הערה : מבוטח זכאי להמיר את שעות הסיעוד לשירותי סיעוד
אחרים, בהתאם למפתח יחידות השירות הקבוע בלוח ח'2 לחוק
הביטוח הלאומי.

32. אספקת מכשירי ניידות ושיקום המפורטים בפרט 4 לתוספת
השלישית, למבוטח זכאי לפי פרק ה'2." ;

(10) בתוספת השלישית, בפרט 4, בכותרת, בסופה יבוא "למעט למבוטח
זכאי לפי פרק ה'2".

תיקון חוק הביטוח 2. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-111995 –
הלאומי

¹¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

- (1) סעיפים 223 עד 236 – בטלים ;
- (2) בסעיף 320 –
- (א) סעיף קטן (ב) – בטל ;
- (ב) בסעיף קטן (ו), פסקה (6) – תימחק ;
- (3) בלוח ח', בפרט (ז)(1), במקום פסקת משנה (ג) יבוא :
- (ג) "מבוטח הזכאי לשעות סיעוד או לשירותי סיעוד לפי פרק ה'2 לחוק ביטוח בריאות" ;
- (4) בלוח ח', בפרט (ז)(2), אחרי פסקת משנה (ה) יבוא :
- "(ו) מחלקה ייעודית בבית חולים שתפקידה מתן מענה ושירות למבוטחים סיעודיים."
- (5) בלוח י"ז, בפרט 46 –
- (א) במקום האמור בטור א' יבוא "זכאות לשירותים לפי פרקים ה'1 או ה'2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי" ;
- (ב) במקום האמור בטור ב' יבוא "סעיפים 23 ו-23ח לחוק ביטוח בריאות".

3. (א) תחילתו של חוק זה ביום¹²

(ב) השרים, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבעו בתקנות הסדרים מיוחדים בתקופת המעבר שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום תחילתו, לרבות הסדרת היחסים ותחומי האחריות בין משרדי הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, נותני השירותים והמבוטחים, לרבות הסדרי התשלום הזמניים ביניהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

המדיניות שבאה לביטוי בחוקים שונים וביניהם חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), היא לסייע לקשישים הנזקקים לעזרה סיעודית, אם בקהילה ואם באשפוז. אוכלוסיית הקשישים היא אוכלוסייה חלשה וענייה יחסית לאוכלוסייה הכללית. בנוסף, לאור הארכת תוחלת החיים, צפויה אוכלוסייה זו לגדול משמעותית בשנים הקרובות. כמו כן, התקופה שבה קשישים נמצאים בפנסיה מתארכת. כיום ישנם מספר מוקדים של אי יעילות אשר בכוונת הצעת חוק זו לטפל בהם. ראשית, הנטל הכלכלי

¹² המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

המוטל על משקי הבית בשל הכיסוי הביטוחי הבלתי-מספק אל מול הצרכים; שנית, הפיצול הרב של מבטחים ונותני שירות: המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלאות סיעוד בקהילה, משרד הרווחה והביטחון החברתי בנוגע להשמת זקנים תשושים במעונות, משרד הבריאות בנוגע לאשפוז גריאטרי כרוני, וקופות החולים לגבי מטופל סיעודי מורכב ולגבי סוגי אשפוז וטיפולים רפואיים נוספים. פיצול זה מוסיף לסרבול בטיפול בקשישים, מטיל נטל רב על הקשישים ועל בני משפחותיהם וגורם להעדר תמריצים מספיקים לגורמים המטפלים לפעול לשיקום ושימור מצבם של קשישים, להשאתם בקהילה ולמניעת הידרדרות מצבם הרפואי והתפקודי.

ריבוי התחלואה וחוסר העצמאות המאפיינים את הקשיש הזקוק לעזרה סיעודית מחייבים טיפול בידי צוות רב-תחומי, תוך תיאום בין הגורמים המטפלים, וניהול נכון וקיומו של מערך תומך. הניתוק הקיים כיום בין גורמים טיפוליים והפיצול בין המשרדים האחראים פוגע באיכות הטיפול הרפואי-סיעודי בקשישים, מתבטא גם בחוסר אחידות בקריטריונים, וגורם לעומס כלכלי, רגשי ובירוקרטי על המשפחות, לתמריצים הפועלים בכיוונים שאינם לטובת הקשיש, לכפל עלויות ולחוסר יעילות.

דוח מבקר המדינה מס' 61' לשנת 2010 הצביע על ליקויים בכל הקשור לטיפול בצורכי הקשישים בקהילה ובמוסדות האשפוז. בין יתר המלצותיו, המליץ המבקר לקדם שינויי חקיקה שיתאימו את מספר שעות הטיפול הניתנות לקשיש למידת תלותו בזולת, ולהבטיח שהזכאים אכן יקבלו את מלוא גמלת הסיעוד כקבוע בחוק. כמו כן, המליץ המבקר למשרד הרווחה והביטחון החברתי, למוסד לביטוח לאומי ולמשרד הבריאות, לבחון את תהליך בחינת הזכאות לגמלת הסיעוד, להגדיר מחדש את תפקידיהן של הוועדות המקומיות-מקצועיות, לקבוע כללים בנוגע לביקורי העובדים המקצועיים בבתי הקשישים ולהקפיד על ביצועם בתדירות המתחייבת על מנת לפקח ביעילות על טיב שירותי הסיעוד הניתנים לקשישים.

לאור כל האמור לעיל וכדי להגביר את היעילות באספקת השירותים לאוכלוסייה חלשה זו מוצעים בהצעת חוק זו הסדרים לשם השגת המטרות הבאות: הבטחת כיסוי אוניברסלי בהיקף ראוי ובר קיימא לאורך שנים, הגברת היעילות של מערך אספקת השירותים לנזקקי סיעוד, שיפור הנגישות ואיכות שירותי השיקום והסיעוד לנזקק ומשפחתו, עידוד הטיפול הסיעודי במסגרת הקהילה והעצמת יכולת ההתמודדות של המשפחה, הגברת היעילות של פעילות הרגולציה והאכיפה, היערכות להתפתחויות עתידיות בתחום תשתיות הטיפול בחולה הסיעודי ושיפור הידע ושקיפות המידע למבוטחים.

מוצע שמשרד הבריאות ישמש כגורם האחראי על מגוון הטיפולים הרפואיים-סיעודיים בקשיש הנזקק לסיעוד, וקופות החולים יוגדרו כגורם האחראי על אספקת השירותים וניהולם, במתכונת דומה לזו שבה פועלות הקופות כיום בכל הקשור לשירותי בריאות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

באופן זה ינוצלו תקורות קיימות בקופות החולים וינוצל הניסיון הניהולי העשיר שלהן באספקת שירותים בקהילה. בנוסף, יביא הדבר לקיומו של רצף טיפולי בקשיש, עם תמריץ להשקיע ברפואה מונעת ומשקמת, והשאת המבוטח בקהילה בקרב משפחתו, כל עוד הדבר אפשרי.

מוצע כי האחריות הכוללת למתן טיפול סיעודי לקשישים נזקקי סיעוד בקהילה ובמוסדות תועבר לקופות החולים, ובכלל זה באמצעות העברת האחריות למתן שעות סיעוד בבית, במקום גמלת סיעוד, מהמוסד לביטוח לאומי אל הקופות.

בנוסף, מוצע להרחיב את הזכאות של נזקקי הסיעוד לשירותים במימון ציבורי, ולהעביר את האחריות הביטוחית לנזקקי הסיעוד, תשושי נפש וסיעודיים, בין בקהילה ובין באשפוז לידי קופות החולים.

סעיף 1

סעיף זה מציע, בין השאר, להוסיף לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שני פרקים: פרק ה'1: עוסק בהשמת נזקק סיעודי במעון או במוסד סיעודי: מוצע להגדיר סוגים שונים של אוכלוסיות שזכאיות לשירותי סיעוד, להגדיר באילו תנאים מתקיימת זכאות להשמה באשפוז סיעודי והוראות בדבר ההשתתפות העצמית בעלויות האשפוז.

פרק ה'2: עוסק בעזרה סיעודית קהילתית: מוצע לקבוע הסדרים בדבר זכאות של מבוטחים לשעות סיעוד או שירותי סיעוד אחרים, בדבר בחינת מידת התלות של המבוטחים, שיעור הזכאות שתיקבע לפי מבחני הכנסה, בדבר הכנת תכנית לקבלת שעות סיעוד ושירותי סיעוד אחרים על ידי קופות החולים, בדבר אפשרות לקבלת תשלום חודשי לידי הזכאי כתחליף לקבלת שירותי הסיעוד, בדבר תמיכה במטפל העיקרי בנזקק הסיעודי וכן לקבוע הוראות נוספות בנושא תמיכה סיעודית בקהילה. כמו כן, מוצע להוסיף לתוספת השנייה לחוק פירוט היקף של שעות הסיעוד והשירותים האחרים שלהם זכאי נזקק סיעודי בקהילה לפי רמות התלות.

כמו כן, מוצע להוסיף את שני הנושאים שמוסדרים בפרקים אלה לתוך סל שירותי הבריאות.

סעיף 2

סעיף זה מציע לבטל את הפרק העוסק בביטוח סיעוד בחוק הביטוח הלאומי, ולקבוע כעבודה מועדפת עבודה שמבוצעת במחלקה ייעודית למבוטחים סיעודיים בבית חולים.

סעיף 3

סעיף זה קובע כי שר הרווחה והביטחון החברתי ושר הבריאות יקבעו בתקנות הסדרים לתקופת המעבר שעד למועד תחילתו של החוק המוצע. ההצעה מבוססת בחלקה על המסמך "ביטוח ציבורי בתחום הסיעוד: מתווה לרפורמה", שנמצא באתר משרד הבריאות. הצעת דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2662).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)